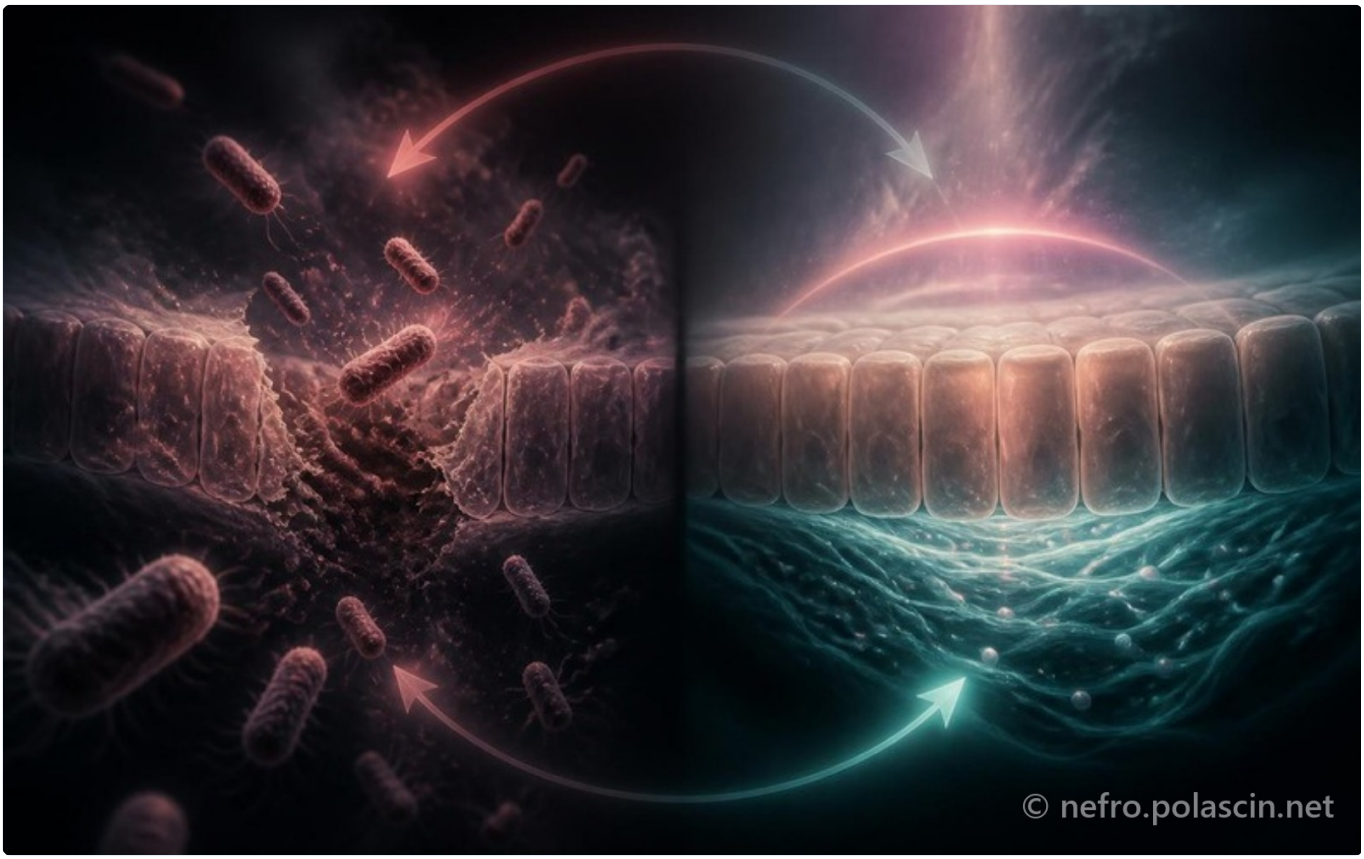
Opakované infekcie močových ciest u starších žien a prepojenie s urogenitálnym syndrómom menopauzy (GSM): diagnostika, antibiotiká a prevencia bez nich

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.07.2026



Poloschematická vizualizácia. Kým sa neobnoví bariéra, infekcie sa vracajú – antibiotikum rieši epizódu, nie príčinu.

Opakované infekcie močových ciest (recurrent UTI) sú u starších žien časté a klinicky náročné. Nestačí len „potvrdiť infekciu“: časť ťažkostí infekciu napodobňuje, hoci nejde o aktívnu bakteriálnu cystitídu. Hrozí tak zbytočná antibiotická liečba s nepriaznivými dôsledkami pre pacientku aj pre antimikrobiálnu rezistenciu.

V tomto podcastovom rozhovore na Medscape (InDiscussion) sa moderátorka rozpráva s urologickou expertkou Dr. Melissou R. Kaufmanovou o praktickom prístupe k diagnostike a manažmentu recidivujúcich UTI u starších žien, s dôrazom na úlohu urogenitálneho syndrómu menopauzy (GSM) a na možnosti prevencie bez antibiotík.

1) Ako pristupovať k žene s recidivujúcimi UTI

Prvým krokom je podľa rozhovoru cielená anamnéza zameraná na symptómy a ich kontext. Dôležité sú najmä:

- predchádzajúce urologické a gynekologické zákroky,
- východiskové symptómy z dolných močových ciest,
- črevné ťažkosti ako možný zavádzajúci faktor (confounder),
- vzťah symptómov k spúšťačom a k predošlej liečbe.

Kľúčové je podľa expertky aj gynekologické (pelvické) vyšetrenie, ktoré môže odhaliť alternatívne príčiny alebo prispievajúce faktory, ako sú vaginálna atrofia pri GSM, uretrálne divertikulum alebo prolaps panvových orgánov.

2) Diagnostická logika: kedy myslieť na UTI a kedy nie

Rozhovor zdôrazňuje, že pri podozrení na akútnu cystitídu má **negatívny výsledok moču** (bez nitritov a bez

leukocytov v moči) významnú negatívnu prediktívnu hodnotu, takže môže pomôcť infekciu skôr vylúčiť.

Pri vzorkách zo stredného prúdu moču („clean catch“) je kontaminácia častá, čo môže viesť k zbytočnej antibiotickej liečbe. Pri nejasnosti rozhovor odporúča zvážiť **katetrizačný odber** pre presnejšie posúdenie.

Pri hodnotení močového nálezu má význam pyúria, konkrétne **viac ako 5 leukocytov/HPF** pri mikroskopii. Treba tiež rozlišovať medzi:

- bakteriálnou cystitídou a
- stavmi, ktoré môžu UTI napodobňovať (intersticiálna cystitída, syndróm bolestivého mechúra, myofasciálne panvové ťažkosti, hyperaktívny močový mechúr).

3) Prečo antibiotiká pri „pozitívnom náleze“ nie sú automaticky správne

Jednou z hlavných myšlienok rozhovoru je, že aj pozitívny nález v moči (napr. nitrity + leukocyty) nemusí znamenať klinicky relevantnú infekciu. Podľa expertky môže ísť aj o bežnú komenzálnu prítomnosť baktérií v prostredí dolných močových ciest.

Starší pacienti navyše môžu mať zmenené vnímanie symptómov, takže ani „zjavná“ baktériúria nemusí korelovať s klinickým obrazom dyzúrie.

4) Nadužívanie antibiotík treba riešiť systémovo: urobióm, stewardship a nadmerná diagnostika

Rozhovor dáva do súvisu urobióm (mikrobióm močových ciest) a riziko systémovej dysbiózy pri častom podávaní antibiotík. Cieľom nie je len „vyhnúť sa *C. difficile*“, ale mať širší pohľad na vplyv antibiotík na mikrobiotu vrátane možných dlhodobých následkov.

V praxi to znamená, že prístup „len to predĺžim, rozšírim spektrum alebo zvýšim dávku“ nie je pri recidívach podľa rozhovoru opodstatnený, ak preň nie sú dôkazy. Práve takýto postup môže zvyšovať selekčný tlak a zhoršovať rezistenciu.

5) Prevencia recidivujúcich UTI bez (automatického) antibiotika

Rozhovor zdôrazňuje preventívne možnosti, s ktorými počítajú aktuálne odporúčania (guidelines) pre recidivujúce UTI.

Hydratácia

Jedným z najmenej rizikových a v praxi odporúčaných krokov je **príjem tekutín približne 1,5 litra vody denne**, čo môže pomôcť znížiť riziko infekcie.

Brusnice a D-manóza

Rozhovor vysvetľuje mechanizmus väzby *E. coli* na bunky cez fimbrie a manózové receptory. D-manóza a proantokyanidíny z brusníc majú teoreticky obmedzovať schopnosť baktérií viazať sa a kolonizovať.

Metenamín hippurát

Odporúčaný je aj **metenamín hippurát**, ktorý sa v kyslom prostredí mení na bakteriostatickú zlúčeninu (formaldehyd + amoniak). V praxi sa často kombinuje s vitamínom C, aby sa podporila kyslosť moču.

Lokálne vaginálne estrogény pri GSM

Najdôležitejším preventívnym pilierom je v tomto rozhovore **lokálny nízkodávkový vaginálny estrogén** u žien s GSM. Rozhovor opisuje GSM ako spektrum zmien pri poklese estrogénov a androgénov, s vplyvom na:

- vaginálnu sliznicu (atrofia, znížená vlhkosť, krehkosť),
- pH a mikroprostredie,
- a v dôsledku toho aj vyššiu náchylnosť na recidivujúce UTI.

Rozhovor to vysvetľuje stratou ochranných laktobacilov pri hypoestrogénnom stave, čo umožní premnoženie patogénov a ich prístup do močových ciest.

6) Nefrologický pohľad: prečo by nás to malo zaujímať

Podcast sa venuje najmä urologickému a gynekologickému pohľadu, téma je však dôležitá aj pre nefrológa, a to z dvoch dôvodov:

1. U starších pacientov s CKD často opakovane vznikajú epizódy symptómov „podobných UTI“, kde rozhodnutie antibiotiká verzus neinfekčný stav býva zásadné.
2. Pacienti s CKD môžu byť zraniteľnejší voči nežiaducim účinkom antibiotík, polyfarmácii a zmenám nutričného alebo mikrobiómového prostredia.

V nefrologickej starostlivosti je preto rozumné prepojiť urologické odporúčania s nefrologickým princípom rozvážnosti: potvrdiť infekciu čo najpresnejšie podľa kliniky a výsledkov moču a pri recidívach aktívne riešiť prispievajúce stavy, najmä GSM, aby sa antibiotiká nemuseli používať „len zo zvyku“.

Zdroj: *Anne Lenore Ackerman, Melissa R. Kaufman, „Recurrent UTIs in Older Women and Association With Genitourinary Syndrome of Menopause (GSM)“, Medscape InDiscussion: UTI podcast (2026).* *Link na zdroj*.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=recidivujuce-uti-starsie-zeny-gsm · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.